Aspectos psicológicos, psicosociales y cognitivo-conductuales del dolor. Terapias psicológicas

Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Psicología del dolor. Aspectos generales
4. Papel de la terapia ocupacional en el paciente con dolor
5. Bibliografía

Objetivos

- Mostrar al alumno las bases del manejo psicológico del paciente con dolor.
- Tratar las principales terapias y técnicas psicológicas aplicables al paciente con dolor.
- Dar a conocer la relevancia de las terapias ocupacionales en el abordaje multidimensional del paciente con dolor.

Introducción

La inclusión de la psicología, como parte del manejo multidisciplinar del dolor, se ha hecho indiscutible desde que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) estableciera la última definición del dolor que por el momento es la más aceptada: "el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en un tejido, o descrito en términos de dicho daño"[1].

Muchos son los autores que han estudiado el efecto que el componente psicológico tiene sobre el dolor, así, los trabajos de Airaksinen muestran que los tratamientos médicos conservadores, focalizados exclusivamente en el empleo de fármacos, tienen una efectividad de baja a moderada en el control del dolor lumbar crónico[2], por otro lado, se ha mostrado que fenómenos como la catastrofización, las creencias sobre el miedo y las estrategias de evitación hacia el dolor, contrarrestan los efectos beneficiosos del tratamiento convencional y rehabilitador[3,4].

A continuación, se tratan los tres ámbitos fundamentales del abordaje psicológico del dolor. Por un lado, el abordaje fisiológico que actúa tratando de controlar las alteraciones puramente orgánicas que provocan o influyen en el proceso del dolor.

Asimismo, se abordará el ámbito conductual y se estudiarán los métodos aplicados para generar estrategias para inhibir las conductas negativas del dolor y potenciar conductas positivas de afrontamiento del dolor.

En tercer lugar, se expondrán los conceptos actuales acerca de las terapias cognitivo-conductuales, aplicadas más recientemente y que tiene como objetivo actuar sobre los factores cognitivos elaborados por el paciente a partir de su vivencia del dolor.

Si bien las terapias ocupacionales no forman parte de las terapias psicológicas propiamente dichas, su participación en el plan terapéutico del dolor es imprescindible, dada la multiplicidad de aspectos de la vida cotidiana que aborda y deben ser estudiadas por el gran impacto de estos métodos terapéuticos en el estado emocional y social del paciente en cualquiera de los grandes síndromes dolorosos.

Psicología del dolor. Aspectos generales

En la actualidad, se asume a nivel generalizado el aspecto multidimensional del dolor que implica, de forma imprescindible, los aspectos psicológicos que envuelven al paciente en la percepción, afrontamiento, evolución y pronóstico del dolor agudo y crónico.

Muchas han sido las teorías que han abordado los aspectos psicológicos del dolor, con mayor o menos grado de aceptación por parte de la comunidad científica. De entre ellas, una de las más apoyadas por estudios experimentales es la *Teoría del apego*, publicada por primera vez en 1951[5], por el doctor en psiquiatría, John Bowlby, y desarrollada entre 1969 y 1980.

La *Teoría del apego* determina que las relaciones que mantiene el niño en las etapas iniciales de su vida, con respecto a sus cuidadores, tienen un efecto considerable en la capacidad futura de afrontar situaciones estresantes.

Actualmente, se acepta que el desorden de apego genera conductas anómalas en el adulto, esto condiciona también el ámbito de la salud y existen multitud de estudios que asocian la presencia de dolor crónico con desórdenes en relaciones de apego en la primera infancia[6-9].

También se ha estudiado en el ámbito de la psicología una relación entre aspectos de la personalidad asociados a la incidencia de dolor crónico, así como a su pronóstico. En este sentido, los rasgos asociados al dolor crónico son la hipocondriasis, la histeria y la depresión.

No obstante, esta relación no es muy clara, y otros autores consideran que ciertos rasgos de personalidad están asociados más bien a aspectos psicológicos negativos, que relacionados al dolor en sí, como podría ser el sufrimiento y la discapacidad[10,11].

Las teorías psicológicas, que relacionan el dolor con aspectos conductuales o de aprendizaje ante el dolor[12,13], han tenido una gran importancia, más recientemente. De este modo, , Fordyce abordó la importancia de la corrección de conductas negativas del dolor.

Fordyce parte del hecho de que el dolor no es medible, si no es a partir de las conductas que genera. Con esta premisa, se establece la diferencia entre el 'dolor respondiente': que incluye las conductas perfectamente explicables por la lesión que se padece, y el 'dolor operante': integrado por conductas que no se pueden explicar por una lesión que, en muchos casos, se ha resuelto.

Según su teoría, la situación de dolor prolongada en el tiempo es un factor de riesgo para que el paciente integre las conductas generadas por el dolor, más allá de la duración del proceso doloroso (conductas operantes).

Por lo tanto, la solicitud de ayuda, las posturas antiálgicas, el llanto o la queja verbal del dolor pueden quedar profundamente inculcadas en el paciente, y tendrán un efecto negativo en la evolución del dolor, además de afectar en procesos dolorosos posteriores.

Las conductas mal aprendidas aumentan el riesgo de cronificación de cualquier proceso que cursó con dolor a lo largo de la vida del paciente y es necesario tratar de corregirlas.

El manejo de la dimensión psicológica del dolor deben estar en manos de especialistas psicólogos o psiquiatras, como parte del manejo interdisciplinar del dolor. Una de las primeras tareas a abordar en el manejo de la dimensión psicológica y emocional del dolor es hacer comprender al paciente de la necesidad de incluir las terapias psicológicas en el control del dolor.

A menudo, el paciente que sufre dolor crónico no es consciente de los factores personales o ambientales que afectan negativamente a la evolución de su dolor o de cómo su dolor afecta su estado psicológico.

Es necesario preparar al paciente, informarle de la necesidad de terapia psicológica como parte de su tratamiento de dolor, también, mostrarle los beneficios que se esperan de esta actuación para potenciar la aceptación del tratamiento y la eficacia del mismo.

Las terapias psicológicas se evalúan dentro del marco de referencia establecido por la Sociedad de Psicología Clínica, perteneciente a la Asociación Americana de Psicología *(Tabla 1)*.

Los objetivos de las terapias psicológicas ante el dolor se muestran en la *tabla 2:*

- **Técnicas fisiológicas en el manejo del dolor**

  Las terapias psicológicas basadas en el tratamiento de factores fisiológicos asociados o desencadenantes del dolor, como contracturas musculares o alteraciones del automatismo al dolor, han demostrado tener un efecto beneficioso, no sólo a nivel del trastorno fisiológico en sí, sino en la evolución global del dolor.

  Existen dos terapias empleadas con gran frecuencia en este modelo terapéutico, estas son efectivas considerablemente con la práctica en casa, por lo tanto, el paciente debe ser entrenado por especialistas.

  - *Relajación:*

    La efectividad de la relajación se explica por el hecho de que el dolor genera una situación de estrés en el paciente, este se traduce en un estado de tensión muscular que, por sí mismo, puede ser el origen del dolor[14]. El objetivo de la relajación en el manejo del dolor es disminuir los niveles de tensión muscular, para lo cual los ejercicios de relajación están dirigidos *(Tabla 3).*

    Los dos tipos más empleados son, por un lado, la relajación progresiva descrita por Jacobson, en 1929. Consiste en la relajación del cuerpo y del estado mental en tres fases temporales. Comenzando por pequeños grupos de músculo liso y finaliza en un estado de relajación mental y física, profundas y duraderas.

    El segundo tipo más habitual es el entrenamiento autógeno de Schultz, publicado por primera vez en 1932[15], y basado en la autosugestión como metodología básica para el control de la sintomatología derivada del estrés; esta última terapia está indicada en el control de la situación de estrés, y se ha empleado para el tratamiento de padecimientos como la hipertensión arterial, las cefaleas o los estados psicosomáticos.

    En el ámbito del dolor, las técnicas de relajación pretenden generar un estado de relajación ante la tensión muscular, que viene dada por el estado de sufrimiento y que desemboca en un estado de estrés y ansiedad que empeora la percepción propia del dolor.

    Si bien no existe en la actualidad evidencia clínica de que las técnicas de relajación sean efectivas por sí solas en la disminución del dolor, sí parece aceptado que, asociados a otros métodos terapéuticos psicofisiológicos, podrían mejorar la situación clínica. A pesar de esto, se emplea de forma habitual en el control del dolor en las cefaleas donde parece que los resultados son más determinantes[16,17].

  - *Técnicas de biofeedback:*

    La técnica de biofeedback pretende que el paciente controle un estado autonómico, conociendo una serie de variables fisiológicas, de las que habitualmente no es consciente, para aprender a controlarlas.

    El conocimiento del estado de variables fisiológicas, relacionadas con el estrés de los músculos, permitirá al paciente establecer estrategias de concentración y relajación que le permitirá un control de estas variables.

Sociedad de Psicología Clínica (Asociación Americana de Psicología)
Niveles de evidencia clínica según la Asociación Americana de Psicología
• Nivel I: tratamientos con evidencia fuerte. • Nivel II: tratamientos con evidencia modesta o probablemente eficaces. • Nivel III: tratamientos con escasa evidencia o prometedores.

Tabla 1. Validez de terapias psicológicas. Sociedad de Psicología Clínica (Asociación Americana de Psicología).

Objetivos de las terapias psicológicas
Crear conductas adecuadas de afrontamiento ante el dolor.
Incorporar significados positivos a la situación estresante.
Enseñar técnicas específicas adecuadas para el paciente: relajación o técnicas de adaptación a la situación actual.
Mostrar herramientas para el descentramiento de la queja somática y física.
Favorecer estrategias de comunicación emocional.
Discernir los aspectos ambientales no modificables como cambios de clima, factores hormonales, presencia de otras comorbilidades, factores asociados a la evolución del propio dolor y potenciar el nivel de adaptación del paciente a los mismos.

Tabla 2. Objetivos de la terapias psicológicas aplicadas al dolor.

Pautas de las técnicas de relajación en el dolor
Desviar la atención del dolor, lo que repercutirá de forma positiva en el paciente.
Disminuir los niveles de ansiedad que colaboran a la percepción de dolor.
Permitir el descanso y el sueño sin usar fármacos.
Potenciar en el sujeto la sensación de control y autoeficacia al dotarle de una estrategia de afrontamiento.

Tabla 3. Pautas de las técnicas de relajación en el dolor.

De este modo, se pretende actuar sobre la tensión muscular asociada a las cefaleas tensionales y otras patologías asociadas a sobrecarga tensional muscular como la lumbalgia.

El paciente recibirá una información precisa a través de métodos electrónicos, mecánicos y químicos, y a partir de un entrenamiento basado en métodos de retroalimentación o feedback, aprenderá a controlar estas variables autonómicas de forma voluntaria[18]. Según Shellenberger y Green[19], el biofeedback requiere que el paciente cumpla una serie de requisitos para obtener resultados positivos *(Tabla 4):*

Según estos autores, una buena práctica de estas técnicas puede transcender desde el puro control de lo fisiológico, al desarrollo de conductas cognitivas y conductuales, con efectos muy positivos en la evolución del dolor.

Sin embargo, a pesar de que aparentemente podría tener buenos resultados como técnica psicofisiológica para el control del dolor crónico, no existe por el momento evidencia que avale sus resultados.

Únicamente hay estudios que parecen apoyar su empleo en las cefaleas[20,21] y en las patologías temporales[22,23], con un grado de evidencia de II, según la Asociación Americana de Psiquiatría.

- **Técnicas conductuales en el control del dolor:**

  Estas técnicas se basan en el abordaje de las conductas del paciente con respecto al dolor, lo que se llama el condicionamiento operante.

  Tienen su origen en la Teoría de la conducta operante descrita por Fordyce, aquella que se aprende como consecuencia de la presencia o no, de refuerzos a dicha conducta. La conducta operante muestra la capacidad del organismo para organizar los estímulos y la conducta en términos de medios-fines.

Requerimientos para biofeedback
El paciente debe conocer la metodología de la técnica.
El paciente debe ser informado de los objetivos y que estos sean claros.
El paciente debe tener capacidad de entendimiento y colaboración.
Enseñanza práctica por parte de especialista.
Aplicar técnicas de refuerzo positivo en el paciente.
Se debe trabajar en la motivación del paciente.

Tabla 4. Requerimientos para biofeedback según Shellenberger y Green.

El objetivo principal de estas terapias psicológicas es disminuir el grado de afectación funcional que sufre el paciente debido a su experiencia de dolor[24]. Se basan en la teoría de que el comportamiento de un individuo será siempre reforzado si se obtiene una consecuencia interpretada como positiva por él.

La realización de las técnicas conductuales precisa que el paciente y su entorno más cercano adopte una actitud activa y motivada hacia la eliminación de conductas favorecedoras del dolor y el refuerzo de conductas incompatibles con la inhabilitación causada por el dolor. Lo que favorecerá una mejor respuesta a esta técnica terapéutica.

No todas las circunstancias y personas son candidatas a las terapias conductuales, se considera que el dolor debe ser crónico, los pacientes deben tener capacidad para desarrollar conductas operantes ante el dolor, sobre las que se enfocará el tratamiento y, por último, el sujeto debe tener un entorno que se muestre positivo ante la aplicación de estas terapias, debe comprenderlas y participar activamente en su desarrollo.

La aplicación de estas terapias no será efectiva de forma aislada, sino que deber ser una parte del tratamiento psicológico del paciente. Habitualmente, están enfocadas a revertir conductas perniciosas como son el consumo excesivo de fármaco y la disminución de las actividades cotidianas, ocio, labores habituales, y actividad física que condiciona un aislamiento social del paciente[13,25]. Además, se han demostrado efectividad de nivel de evidencia I en cefaleas y lumbalgia[26,27].

- **Técnicas cognitivas en el manejo del dolor:**

  El objetivo de las técnicas cognitivas en el control del dolor es la modificación de la forma en la que el paciente evalúa, analiza e interpreta su dolor.

  El aspecto cognitivo del dolor tendrá una repercusión en los aspectos conductuales del paciente, si el análisis de la situación del dolor crónico está distorsionada, desencadenará en conductas inadecuadas que incrementarán el impacto negativo del dolor en la vida del paciente.

  Una vez asumido el componente cognitivo del dolor en las últimas décadas, comienzan a desarrollarse las terapias cognitivo-conductuales que tienen un papel muy favorable en el control del dolor cuando se aplican como adyuvantes a terapias médicas; la asociación de ambas aporta mejores resultados en el manejo del dolor que las terapias médicas por sí solas[28-30].

  Las diferentes técnicas cognitivas emplean múltiples herramientas como facilitar información sobre el síndrome de dolor, actúa sobre los aspectos emocionales, fisiológicos y cognitivos que pueden favorecer o impedir un adecuado afrontamiento del problema, y ayuda al paciente en el abordaje más adaptativo. Las principales técnicas cognitivas que se aplican hoy en día en el tratamiento del dolor son:

  - *Reestructuración cognitiva:*

    Es un modelo de terapia cognitiva adaptada al dolor. El objetivo principal de la reestructuración cognitiva será que el paciente desarrolle estrategias que le permitan detectar y modificar las percepciones irreales, desadaptadas y negativas del paciente con respecto a su dolor. En este modelo, se establece que el problema es la interpretación y el pensamiento negativo e irreal que genera la situación de dolor[32,33].

    Para ello, se aplican técnicas que permiten al paciente:

    » Detectar las emociones que está desarrollando como consecuencia de su dolor: ira y negatividad.

    » Detectar los pensamientos distorsionados: polarización y magnificación.

    » Establecer formas alternativas y positivas de valoración del dolor, estableciendo ideas más realistas de la situación.

    » Este modelo de terapia cognitiva tiene el inconveniente de su dificultad de aplicación, debido a que precisa de personal altamente entrenado y conocedor de la patología que se está tratando.

  - *Inoculación de estrés, adaptada al dolor crónico*[34,35]:

    El objetivo es el mismo que en la terapia de reestructuración cognitiva, si bien en la terapia de inoculación al estrés se valoran también componentes emocionales y fisiológicos. Como la anterior técnica, la aplicación de esta terapia requiere personal con formación especializada. Está claramente diferenciada en tres fases:

    » Fase educacional o de conceptualización: define el dolor y muestra cómo la interpretación del dolor influye en su evolución.

» Fase de adquisición y entrenamiento de habilidades específicas: se trabajará en las diferentes dimensiones del dolor, empleando técnicas de relajación y biofeedback para un control de la dimensión psicofisiológica del dolor, también, técnicas de control, afrontamiento y refuerzo positivo para combatir la dimensión emocional del dolor.

» Fase de puesta en marcha: en esta el paciente aplicará las técnicas aprendidas, en primer lugar, en situaciones de simulación, imaginadas o mediante el role-player, y posteriormente en la situación real de dolor.

En la actualidad, se está desarrollando la tercera generación de terapias cognitivas; se diferencian de las anteriores en que incluyen en la valoración y terapia del problema el concepto del contexto, abandonando el modelo dual de las terapias cognitivas previas, basado en la conexión entre percepción física y los aspectos cognitivos propios de la dimensión mental. Algunas de las más representativas de entre las que se aplican al dolor son:

- La terapia de aceptación del compromiso:

  Un tipo de terapia que resulta útil en casos muy complejos. Su objetivo principal es lograr la aceptación del sufrimiento asociado al dolor, como parte de la existencia. Su base terapéutica está en abolir las conductas de evitación y promocionar la aceptación de la presencia del dolor y la adaptación de los hábitos vitales al mismo. Con ello, se logra reducir el sufrimiento provocado por el dolor.

  El paciente aprende mediante metáforas que la resistencia al dolor finalmente genera una conducta de sobreatención hacia el mismo, que lo retroalimenta positivamente. La lucha constante para controlar y evitar el dolor genera un estado de estrés que finalmente compromete el bienestar de la persona.

  Según Luciano et al, el resultado que se pretende conseguir es que la persona no evite todo lo que piensa o siente, sino que ante estos pensamientos o estas sensaciones que aparezcan, actúe con base a lo que es importante o relevante para él mismo[36,37].

  Para ello, se establecen cuatro aspectos definidos como temáticos en cada sesión de ACT, sobre los que se trabajará sistemáticamente la exposición, la desactivación de funciones y distanciamiento, y el fortalecimiento. Para trabajar estos aspectos se usan metáforas, paradojas y ejercicios de exposición basados en la conciencia plena.

- El mindfulness o atención plena:

  Definido como "la capacidad de poner atención plena sobre una experiencia, en el momento presente, con apertura, flexibilidad y sin enjuiciamiento"[38]. Está igualmente basado en la no evitación del dolor, sino todo lo contrario, en la plena atención sobre el dolor, pero con una mirada que evite prejuicios acerca de la experiencia del dolor.

  Al evitar juicios y valoraciones del dolor, se disminuye la incidencia y la severidad de los cuadros de ansiedad y depresión asociados al mismo. Evitar las conductas de evitación y de control del dolor, permitirá no asociar el dolor a sensaciones de atrapamiento e impotencia.

  Se trata de una técnica psicológica implantada en los años 80 por Kabat Zinn[39], cuya metodología está basada en meditación.

  En forma complementaria se usan ejercicios de yoga para mejorar la conciencia del cuerpo, la resistencia y flexibilidad corporal. Parece tener efectividad como terapia coadyuvante en situación de dolor de difícil control con gran componente afectivo[40-42].

Papel de la terapia ocupacional en el paciente con dolor

La terapia ocupacional es la disciplina sociosanitaria que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa.

Desde este modelo de terapia, se aborda el dolor disminuyendo los efectos sobre la funcionalidad global del paciente y el desempeño de actividades de la vida cotidiana. Con lo que se logrará mejorar la calidad de vida y mantener el mejor grado de bienestar físico y emocional, y el papel social del paciente.

La terapia ocupacional presenta varios modelos de actuación, dependiendo de la patología a tratar y las características del paciente. Por lo tanto, se encuentran el modelo biomecánico, el modelo cognitivo, el modelo de ocupación humana o el modelo de grupo funcional.

Como parte del manejo del dolor desde la terapia ocupacional, es necesario evaluar las características personales del paciente y sus actividades ocupacionales, identificando los problemas y limitaciones específicos de cada caso, así como las posibles barreras socioambientales y físicas que envuelven al paciente.

Una vez establecidos los puntos a actuar, es esencial establecer las metas a alcanzar, estas deben ser realistas y adaptadas a las circunstancias socioculturales del paciente. El conocimiento del objetivo a alcanzar por parte de los pacientes y su entorno cercano facilitarán la implantación de las medidas necesarias y el éxito de la terapia.

El terapeuta ocupacional deberá, asimismo, realizar labores de monitoreo de implantación y efectividad de las medidas realizadas, y establecerá pautas de refuerzo y modificación de las estrategias que no están siendo efectivas *(Tabla 5).*

La aplicación de la terapia ocupacional, en el paciente con dolor, abarca prácticamente todos los síndromes dolorosos, por lo que es un pilar básico en paciente con afecciones osteomusculares, como las artropatías, las lumbalgias o la fibromialgia, donde su valor terapéutico es indiscutible.

No obstante, su efectividad ha sido demostrada en otras patologías como el dolor neuropático o en situaciones especiales como en la paciente gestante y durante postparto[43] y el paciente anciano[44].

La terapia ocupacional también juega un papel importante en el paciente oncológico y en estado terminal, como medida de soporte, tanto al paciente como al entorno más cercano, familiares y profesionales. En esta etapa el enfoque principal de las terapias ocupacionales es el control del dolor, desde todas las facetas que lo componen, físico, emocional o anímico.

De esta manera, la terapia ocupacional se dirigirá a medidas posturales para el control del dolor físico, pero también integrará medidas que permitan la integración del paciente en actividades sociales de su vida cotidiana.

La terapia debe facilitar que el paciente siga llevando actividades que le interesen y ocupen su tiempo, incluir en su vida diaria actividades de meditación y relajación, y mantener su rol en cuanto a la capacidad de participar en decisiones que le afecten personalmente y a su entorno[45].

Bibliografía

1. International Association for the study of Pain. The subcommittee on Taxonomy. Classificacion of Chonic Pain. Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain 1986; suppl.3
2. Airaksinen, O., Brox, J. I., Cedraschi, C. Hildebrandt, J., Klaber-Moffet, J., Kovacs, F., Mannion, A. F., Reis, S., Staal, J. B., Ursin, H., & Zanoli, G. (2006). COST B13 Working Group on Guidelines for Chronic Low Back Pain. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecifi c lowback pain. European Spine Journal, 15, S192-300.
3. Al-Obaidi, S. M., Beattle, P., Al-Zoabi, B., & Al-Wekeel, S. (2005). The relationship of anticipated pain and fear avoidance beliefs to outcome in patients with chronic low back pain who are not receiving worker's compensation? Spine, 30,1051-1057.
4. Jellema, P, van der Horst, H. E., Vlaeyen, J. W. S., Stalman, W. A. B., Bouter, L. M., & van der Windt, D. A. W. M. (2006). Predictors of outcome in patients with (sub) acute low back pain differ across treatment groups. Spine, 31, 1699-1705
5. Bowlby J. Maternal care and mental health, Geneva; WHQ; London HMSQ.New York, Columbia University Press.1951.
6. Meredith P, Ownsworth T, Strong J. A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical Psychology Review. 2008;28(3):407-29.
7. Green CR, Flowe-Valencia H, Rosenblum L, Tait AR the role of childhood and adulthood abuse among women presenting for chronic pain management. Clin J Pain. 2001;17(4):359-64.
8. Sachs-Ericsson N, Cromer K, Hernandez A, Kendall-Tackett K. A review of childhood abuse, health, and pain-related problems: the role of psychiatric disorders and current life stress. J Trauma Dissociation. 2009;10(2):170-88
9. Raphael, H. Chandler, D. Ciccone Is Childhood Abuse a Risk Factor for a Chronic Pain in Adulthood Current Pain and Headache Reports, 8 (2004), pp. 99-110.
10. Ramírez, C. A., López, E, Esteve, R.,. Evaluación de estrategias de afrontamiento, nivel de funcionamiento y edad en personas con dolor oncológico y benigno. Rev. Soc. Esp. Dolor2001. 8: 102-110.
11. Paredes A., Gladys y Pinelo Navarro B. Neuroticismo, afrontamiento y dolor crónico. Revista de Psicología [online]. 2013, n.10 [citado 2019-11-09], pp. 23-33. Disponible en:<http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322013000200003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2223-3032.
12. Loeser JD, Egan KJ. Managing the chronic pain patient. Theory and practice at the University of Washington Multidisciplinary Pain Center. New York: Raven Press; 1989.
13. Fordyce WE. Behavioral methods for chronic pain and illness. St. Luis, MO: Mosby; 1976.
14. Amuntio A. Teoría y práctica de la relajación. Barcelona:Martínez Roca, 1998.
15. Schultz, J.H. Das Autogene Training. Thieme, Leipzig, 1932.
16. Bogaards, M. C. y Terkuile, M. M. (1994). Treatmentof recurrent tension headache- a metaanalytic review. Clinical of Journal Pain, 10,174-190.
17. Holroyd, D. A. (2002). Assessment and psychological management of recurrent headache disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology,70,656-677.

Objetivos de terapia ocupacional en el paciente con dolor
Mantener, incrementar o mejorar la función.
Mantener o incrementar la independencia en el desempeño de actividades (personales, sociales y laborales).
Aliviar el dolor.
Mantener posiciones funcionales cuando sea necesario (mediante el uso órtesis y/o prótesis, o mediante el uso de productos de apoyo y equipamiento adaptado).
Reeducación laboral.
Mantener y/o fomentar rutinas, hábitos y roles satisfactorios.
Retrasar la progresión del daño estructural (cada vez más controlada por el uso de nuevos fármacos).

Tabla 6. Objetivos de terapia ocupacional en el paciente con dolor.

18. Simón MA, Bioffedback. En Caballo VE, ed. Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Madrid: Siglo XXI; 1991; 373-400.
19. Shellenberger RD, Turner J, Green J, Cooney JB. Health changes in a biofeedback and stress management program. Clinical Biofeedback & Health: An International Journal. 1986;9(1):23-34.
20. Nestoriuc, Y., Martin, A., Rief, W. y Andrasik, F (2008). Biofeedback treatment for headache disorders: a comprehensive efficay review. Applied Psychophysiology and Biofeedback2008, 33:125-140.
21. Nestoriuc, Y., Rief, W. y Martin, A. (2008). Meta-analysis of biofeedback for tension-type headache: efficacy, specificity, and treatment moderators. Journal of Consulting and Clinical Psychology.2008 ;76:379-396.
22. Crider, A. B. y Glaros, A. G. (1999). A meta-analysis of EMG biofeedback treatment of temporo-mandibular disorders. Journal of Orofacial Pain 1999; 13:29-37.
23. Medlicott, M. S. y Harris, S. R. (2006). A systematic review of the effectiveness of exercise, manual therapy, electrotherapy, relaxation training, and biofeedback in the management of temporo-mandibular disorder. Physical Therapy 2006; 86:955-973.
24. Labrador FJ, Vallejo MA. Dolor crónico. En: Mayor J, Labrador FJ. Manual de modificación de conducta. Madrid: Alhambra; 1986; 523-56.
25. Philips HC. El tratamiento psicológico del dolor crónico: Pirámide; 1991.
26. APA12. Website on Research-Supported Psychological Treatments. [cited 2012 March, 2]; Available from: http://www.div12.org/PsychologicalTreatments/disorders/pain_main.php.
27. Chambless DL, Ollendick TH. Empirically supported psychological interventions: controversies and evidence. Annu Rev Psychol. 2001; 52:685-716.
28. Epub 2001/01/10. Eccleston, C., Williams, A. y Morley, S. (2009). Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, number CD007407.
29. Morley, S., Eccleston, C. y Williams, A. (1999). Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive-behaviour therapy for chronic pain in adults, excluding headache. Pain, vol. 80, 1-13.
30. Glombiewski, J. A., Sawyer, A. T., Gutermann, J., Koenig, K., Rief, W., & Hofmann, S. G. (2010). Psychological treatments for fi bromyalgia: a meta-analysis. Pain, 151, 280-295.
31. Moix, J. y Kovacs, F.M. (2009). Manual del dolor. Tratamiento cognitivo-conductual del dolor crónico. Barcelona: Paidos.
32. Bados, A., García-Grau, E. (2008). Eficacia y utilidad clínica de la intervención en psicología clínica. Publicación electrónica. http://hdl.handle.net/2445/4962.
33. Rodríguez-Franco, L., Cano-García, F. J., Blanco-Picabia, A. (2004). Assessment ofchronic pain coping strategies. Actas Especialidad Psiquiátrica, 32(2), 82-91.
34. Turk DC, Meichenbaum D, Genest M. Pain and Behavioral Medicine: A Cognitive-Behavioral Perspective: Guilford Press; 1987.
35. Meinchenbaum D. Manual de inoculación de estrés. Barcelona: Martínez Roca; 1987.
36. Luciano MC y Valdivia MS.: (2006b). La terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Fundamentos, características y evidencia. Papeles del Psicólogo, 27(2): 79-91.

37. Luci ano MC, Mo l i na F, Guti érrez O, Barnes D, Val di v i a S, Cabel l o F, Barnes Y,Rodríguez M & Wilson KG(2010). The Impact of Acceptance-Based Versus AvoidanceBased Protocols on Discomfort. Behavior Modification, 34(2): 94-119.
38. Young LA. Mindfulness Meditation: A Primer for Rheumatologists. Rheum. Dis. Clin. North Am. 2011; 37(1): 63-75.
39. Kabat-Zinn J, Lipworth L, Burney R. The Clinical use of Mindfulness Meditation for the Self-Regulation of Chronic Pain. J. Behav. Med 1985; 8(2): 163-90.
40. Morone NE, Greco CM, Weiner DK. Mindfulness Meditation for the Treatment of Chronic Low Back Pain in Older Adults: A randomized controlled pilot study. Pain 2008; 134: 310-319.42.
41. Septhon SE, Salmon P, Weissbecker I, Ulmer C, Floyd A, Hoover K, Studts JL. Mindfulness Meditation Alleviates Depresives Syntoms in Women with Fibromyalgia: Results of randomized clinical trial, Arth. Rheum. 2007; 57(1): 77-85.43.
42. Chiesa A. Serretti A. Mindfulness-Based Interventions for Chronic Pain: A systematic review of the evidence. J. Altern Complement. Med 2001; 17:83-93.
43. Ferigatoa SH, Silvaa CR, Ambrosio L. Corporality of pregnant women and occupational therapy: possible actions in the Primary Health Care. Cad. Bras. Ter. Ocup., São Carlos, v. 26, n. 4, p. 768-783, 2018.
44. Carreño-Acebo ME, . Cañarte-Mero SB, Delgado-Bravo WM. El terapeuta ocupacional y su rol con pacientes geriátricos. Dom. Cien.Vol. 2, núm. 4, oct., 2016, pp. 60-71.
45. Astudillo W, Mendinueta C, Astudillo E. Cuidados del enfermo en fase terminal y atención a su familia. Segunda edición, Ediciones Universidad de Navarra S. A. Pamplona, 1995.